

Fecha Última Actualización: 31-05-2022 14:52:22

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Francisco Enrique Rodriguez Herrera
Edad : 77a 3m 25d
Dirección : Los Sonetos N 833

Rut : 4.858.035-1
Fecha Nacto: 06/02/1945
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1527904
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 6841 5169

N° Epicrisis
309335

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 17/05/2022 11:24

Días Estadía: 14

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 31/05/2022 14:05

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Aneurisma aorta abdominal roto

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

COMENTARIO DE INGRESO UCI

FI UCI 17/05/22
FI CASR 17/05/22

ANTECEDENTES

MORBIDOS: AAA con indicación Qx sin controles de Marzo 2021, Hipotiroidismo, Trastorno del Animo, ACV 2018.

FÁRMACOS: Sertralina 50 mg ¿ Levotiroxina 125 ug.

HABITOS: Tabaquismo suspendido hace 6 años IPA 30

ALERGIAS: Niega

QX: Hernioplastía inguinal izquierda

ANAMNESIS PRÓXIMA

Paciente en estudio prequirúrgico para aneurisma retomado el 12/05, se realiza Ecocscopia con FEVI 70%, MIBI dipiridamol (marzo/21) con secuelas de infarto apical inferior 5% subendocárdico sin isquemia residual.

Hoy se encontraba en nuevo estudio MIBI dipiridamol como estudio preqx y presenta dolor abdominal súbito con ecoscopia que muestra líquido libre por lo que se deriva a SU.

Ingres a shock (malperfundido a distal, hipotenso, compromiso cualitativo de conciencia) se indica transfusión masiva y se lleva a pabellón.

En pabellón clampeo 1:18 hasta desclampeo de Iliaca izq y 1:50 hasta desclampeo iliaca derecha, hallazgo de hematoma retroperitoneal se instala prótesis de Dacron 20 x 10.

Transfusión con un total de 10 UGR + 6 Criop + 6 Plq + 4 UPFC pH > 7.3

Sale a UCI para continuar con manejo

EVOLUCION UPC

Paciente presenta en UPC inicialmente mejoría clínica, con disminución de requerimientos de DVA, en plan de disminución de sedación y weaning. Presentando el 27/05 deterioro clínico progresivo, inestabilidad hemodinámica, por lo que se decide exploración quirúrgica el 30/05 evidenciando líquido libre turbio y necrosis intestinal de colon descendente. Se realiza

Fecha Epicrisis : 31/05/2022 14:52

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 31-05-2022 14:52:22

Página 2 de 2

hemicolecotomía izquierda y se deja bolsa de bogotá debido a inestabilidad hemodinámica. Paciente intrapabellón grave, con shock séptico + distributivo, mala respuesta a reanimación. Se continúa reanimación por metas, aporte de calcio EV, Albúmina 4%, Bicarbonato 2/3 molar, con mala respuesta. NE hasta 0.6 mcg/Kg/min + epinefrina 0.3 mcg/Kg/min. Durante control de exámenes presenta súbitamente asistolía al monitor, sin pulso palpable. Se realiza RCP Avanzado por 25-26 minutos en total, administrando en total 4 ampollas de epinefrina + matraz 2/3 bicarbonato + Carbonato de calcio. A los 22 min presenta salida a FV, desfibrilándose con 200J 2 ciclos consecutivos, sin salida ritmo sinusal. Tras 25-26 min de RCP avanzada se constata sin pulso, asistolía al monitor, paro respiratorio, pupilas midriáticas, arreflécticas. Se constata fallecimiento a las 12:40 hrs.

Diagnóstico de Egreso

RUPTURA DE ANEURISMA DE LA AORTA ABDOMINAL - Aneurisma aorta abdominal operado, Necrosis intestinal operada, Shock séptico y distributivo, Paro cardiorespiratorio

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Durante control de exámenes presenta súbitamente asistolía al monitor, sin pulso palpable. Se realiza RCP Avanzado por 25-26 minutos en total, administrando en total 4 ampollas de epinefrina + matraz 2/3 bicarbonato + Carbonato de calcio. A los 22 min presenta salida a FV, desfibrilándose con 200J 2 ciclos consecutivos, sin salida ritmo sinusal. Tras 25-26 min de RCP avanzada se constata sin pulso, asistolía al monitor, paro respiratorio, pupilas midriáticas, arreflécticas. Se constata fallecimiento a las 12:40 hrs.

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Javier Rodriguez Gutierrez
Médico Tratante (Staff)